

Radar de sinais relevantes para a realidade hospitalar nacional

**Portugal
05/2026**

Versão nº 1 de 17-06-2026

Relatório produzido pela PDH
para a produção de informação relevante na área da
farmacovigilância.

RESUMO

A análise integrada da realidade nacional de maio de 2026, cruzada com os sinais de segurança regulamentares do mesmo período, identificou três áreas de relevância para a prática clínica e para a interpretação das notificações de reações adversas a medicamentos (RAM).

Do ponto de vista regulamentar, o PRAC reuniu-se entre 4 e 7 de maio de 2026 sem iniciar ou concluir procedimentos de referral, mas com novos sinais em avaliação, incluindo a associação entre amoxicilina/amoxicilina-clavulânico e encefalopatia. Foram ainda considerados relevantes para a vigilância hospitalar os alertas internacionais sobre avacopan/Tavneos e lesão hepática grave, carbidopa/levodopa e déficit de vitamina B6 com convulsões, bem como alertas do MHRA de maio com impacto em medicamentos e dispositivos usados em contexto hospitalar.

SINAL A — AMOXICILINA/AMOXICILINA-CLAVULÂNICO E ENCEFALOPATIA

Fonte: EMA — PRAC, reunião de 4–7 de maio de 2026 — agenda de sinais em avaliação

EMA — Meeting highlights PRAC 4–7 May 2026: ema.europa.eu

Na agenda do PRAC de 4–7 de maio de 2026, a amoxicilina e a associação amoxicilina/ácido clavulânico surgem como novo sinal em avaliação para encefalopatia. Trata-se de uma avaliação regulamentar em curso, ainda sem conclusão causal definitiva, mas relevante pelo peso que os beta-lactâmicos mantêm habitualmente no perfil hospitalar de notificações de reações adversas a medicamentos.

A prioridade não é restringir a utilização destes antibióticos, mas reforçar a caracterização das reações adversas e identificar casos compatíveis com neurotoxicidade ou encefalopatia, sobretudo quando existam sintomas neurológicos, confusão, alteração do estado mental, convulsões, insuficiência renal, idade avançada ou polimedicação.

O que importa rever nos casos locais

- Rever os casos de amoxicilina, amoxicilina-clavulânico e penicilinas de largo espectro, procurando sintomas neurológicos e fatores de risco.
- Confirmar se as notificações descrevem cronologia, dose, função renal e evolução após suspensão ou alteração terapêutica.
- Sensibilizar os serviços com maior volume de beta-lactâmicos para registo estruturado de manifestações neurológicas suspeitas.

Grau de prioridade local: **Elevado**

SINAL B - CARBIDOPA/LEVODOPA: DÉFICE DE VITAMINA B6 E CONVULSÕES

Fonte: FDA Drug Safety Communication — carbidopa/levodopa, 20 de março de 2026.

A FDA comunicou a exigência de novo aviso para medicamentos contendo carbidopa/levodopa, associando-os a déficit de vitamina B6 e convulsões, incluindo casos em que as convulsões não responderam a antiepilépticos habituais mas resolveram após administração de vitamina B6.

O sinal é particularmente relevante em ambiente hospitalar pelo peso habitual da terapêutica do Sistema Nervoso Central no perfil farmacoterapêutico e pela proporção elevada de doentes idosos, grupo em que a doença de Parkinson e a polimedicação são frequentes.

O reconhecimento atempado destes sintomas é importante, já que se resolvem com suplementação de vitamina B6, evitando o recurso desnecessário a antiepilépticos adicionais.

O que importa rever nos casos locais

- Verificar se existem notificações de convulsões ou alterações neurológicas em doentes sob carbidopa/levodopa, sobretudo as refratárias a antiepilépticos.
- Considerar a avaliação do estado nutricional/vitamínico em doentes idosos polimedicados em terapêutica prolongada com este fármaco.
- Articular com a Neurologia a possibilidade de suplementação de vitamina B6 antes de escalar terapêutica antiepiléptica em quadros convulsivos de novo nestes doentes.

Grau de prioridade local: Moderado

SINAL C — AVACOPAN (TAVNEOS): LESÃO HEPÁTICA GRAVE E SÍNDROME DE DESAPARECIMENTO DOS DUCTOS BILIARES

Fonte: FDA Drug Safety Communication — Tavneos (avacopan), 31 de março de 2026. [fda.gov](https://www.fda.gov)

A FDA alertou para casos pós-comercialização de lesão hepática induzida por fármaco associados a avacopan/Tavneos, incluindo casos fatais e casos de síndrome de desaparecimento dos ductos biliares (vanishing bile duct syndrome, VBDS). A comunicação descreve 76 casos com evidência razoável de associação causal, 74 com critério de gravidade, incluindo 54 hospitalizações e 8 mortes.

O sinal é relevante em ambiente hospitalar porque o avacopan é utilizado em vasculites ANCA graves, frequentemente acompanhadas em Nefrologia, Reumatologia, Medicina Interna ou Imunologia.

O que importa rever nos casos locais

- Confirmar se há doentes sob avacopan acompanhados na instituição ou em terapêutica partilhada com centros externos.
- Rever notificações de hepatotoxicidade, colestase, icterícia ou prurido em doentes com vasculite ANCA ou terapêutica imunomoduladora.

ARTIGO CIENTÍFICO EM DESTAQUE — TRAMADOL E RAM ASSOCIADAS A OPIOIDES

Razão da escolha: o tramadol mantém-se entre os fármacos mais associados a notificações de RAM em contexto hospitalar, e o artigo analisa precisamente notificações espontâneas de opioides, identificando pares fármaco-RAM dominantes e diferenças por sexo.

Gustafsson et al. analisaram 8.769 notificações de RAM associadas a opioides submetidas ao Netherlands Pharmacovigilance Centre Lareb entre 2003 e 2021, com codificação MedDRA e cálculo de ROR para pares fármaco-RAM, incluindo análises por sexo. O tramadol foi o opioide com maior número absoluto de notificações (2.746; 31,3%), seguido de oxicodona, fentanilo, morfina, buprenorfina e tramadol/paracetamol.

Os pares mais frequentes no conjunto foram tramadol-náusea (197 relatos), tramadol-tontura (122) e oxicodona-náusea (112), destacando-se ainda tramadol-vômito (108) e tramadol-hipersudorese (89).

A leitura clínica principal é que a presença do tramadol no topo das notificações tende a refletir RAM esperadas mas operacionalmente relevantes — náuseas, tonturas, vômitos, hipersudorese, sonolência, prurido, interações e obstipação — e não apenas eventos raros. O estudo mostrou predomínio de notificações em mulheres e uma associação relativamente mais forte de vômitos com tramadol no sexo feminino (ROR mulheres/homens 2,17), enquanto o fentanilo concentrou maior sinal de abuso, uso indevido e erros de medicação.

Isto sugere que os casos de tramadol devem ser revistos por par fármaco-RAM, sexo/idade, contexto perioperatório ou médico e gravidade clínica, sem inferir causalidade apenas a partir da frequência de notificação.

Fonte: Gustafsson M, Matos C, Joaquim J, Scholl J, van Hunsel F. Adverse Drug Reactions to Opioids: A Study in a National Pharmacovigilance Database. Drug Safety. 2023;46(11):1133-1148. doi: 10.1007/s40264-023-01351-y.

CONTEXTO REGULAMENTAR INTERNACIONAL — MAIO 2026

Este mês registaram-se desenvolvimentos regulamentares e operacionais com impacto potencial na prática hospitalar, embora nem todos correspondam a decisões finais sobre medicamentos.

EMA PRAC: sem novos referrals, mas com sinais em avaliação

Na reunião de 4–7 de maio de 2026, o PRAC não iniciou nem concluiu procedimentos de referral e não tinha referrals de segurança em curso. A agenda incluiu, contudo, novos sinais para adoção de recomendação, entre os quais:

- Amoxicilina/amoxicilina-clavulânico e encefalopatia;
- Dapagliflozina e líquen esclero-atrófico;
- GLP-1/semaglutida e neuropatias periféricas ou vôlvo gastrointestinal;
- Ixekizumab e síndrome de Behçet;
- Tocilizumab e vasculite cutânea.

Para a prática hospitalar nacional, o principal cruzamento é o sinal relativo a beta-lactâmicos, dado o peso habitual de penicilinas, amoxicilina e amoxicilina-clavulânico nas notificações de RAM.

Fonte: EMA, Meeting highlights PRAC 4-7 May 2026; EMA, Draft agenda PRAC meeting 4-7 May 2026.

MHRA Safety Roundup: medicamentos e dispositivos

O MHRA publicou a 28 de maio de 2026 um resumo de segurança com alertas sobre descongestionantes nasais contendo xilometazolina/oximetazolina, finasterida/dutasterida, e vários dispositivos, incluindo sistemas de seringas/manifolds para procedimentos angiográficos, sistemas de administração para transfusão sanguínea e balão gástrico Allurion.

Estes temas têm impacto indireto na farmacovigilância hospitalar porque cruzam segurança medicamentosa, dispositivos, consentimento, circuitos de armazenamento e notificação de incidentes.

Fonte: MHRA Safety Roundup: May 2026. [gov.uk](https://www.gov.uk)

NOTA METODOLÓGICA

Este relatório resulta da análise integrada de duas fontes de informação:

- (1) informação regulamentar do PRAC relativa à reunião de 4–7 de maio de 2026;
- (2) comunicações de segurança e dados de imprensa/regulamentares internacionais relevantes para maio de 2026, incluindo FDA e MHRA.

O cruzamento entre sinais regulamentares e a prática hospitalar tem caráter orientador e não substitui a análise clínica individualizada.

Relatório produzido pela PDH para a produção de informação relevante em farmacovigilância.